创新药评价的注意力配置差异与协调路径*

王孝炯[1]，陈海婷[1,2]，刘中全[3]

（1. 中国科学院科技战略咨询研究院，北京 100190；
2. 中国科学院大学公共政策与管理学院，北京 100049；
3. 国家发展和改革委员会创新驱动发展中心，北京 100038）

摘要：创新药评价涉及上市、医保准入和临床使用等环节，跨部门协调需要明确各环节的评价重点及结论适用范围。本文以药监局、医保局和卫健委 2017—2026 年的 51 项政策资料为研究对象，采用自动规则编码和大语言模型编码，从安全性、有效性、经济性、创新性、公平性五个维度比较注意力配置，并结合政策条文与专家访谈解释部门差异。自动规则编码显示，药监局对安全性的注意力占比为 38.12%，医保局对经济性的注意力占比为 78.20%。两种方法均发现，在涉及药品安全的表述中，医保局同时讨论疗效的比例最高。政策条文和访谈表明，部门评价差异与费用保障、药品供应和临床使用等任务有关。跨部门协调应针对同一适应症和目标人群对照评价结论，统筹补充研究，并共享支付、配备和使用信息。

关键词：创新药评价；制度逻辑；注意力配置；政策文本；三医协同

中图分类号：**C934**　　**文献标识码**：**A**

Differences in Attention Allocation in Innovative Drug Evaluation and Coordination Pathways

WANG Xiaojiong[1], CHEN Haiting[1,2], LIU Zhongquan[3]

(1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
3. Center for Innovation-Driven Development, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China)

Abstract: Cross-agency coordination in innovative drug evaluation requires a clear understanding of what each stage assesses and how its conclusions are used. Using 51 policy source entries from China's drug regulation, medical insurance and health administration systems issued between 2017 and 2026, this study applies rule-based and large language model coding to compare attention allocation across safety, efficacy, economic considerations, innovation and fairness. Policy interpretation and expert interviews help explain differences across agencies. Rule-based attention shares are 38.12% for safety in drug regulation and 78.20% for economic considerations in medical insurance. Both coding methods show that, among policy passages concerning drug safety, the share also addressing therapeutic efficacy is highest in medical insurance policy. Policy provisions and interviews link these differences to the coordination of payment coverage, drug supply and clinical use. Coordination should align assessment conclusions for the same indication and target population, connect supplementary research across stages, and share information on payment coverage, institutional availability and actual use.

Key words: innovative drug evaluation; institutional logics; attention allocation; policy text; coordination of healthcare, health insurance and pharmaceuticals

---

*基金项目：国家自然科学基金项目（72074204）。

作者简介：王孝炯（1982—），男，安徽合肥人，中国科学院科技战略咨询研究院研究员。主要研究方向：创新发展政策。

陈海婷（2002—），女，福建建瓯人，中国科学院科技战略咨询研究院、中国科学院大学公共政策与管理学院硕士研究生。主要研究方向：科技创新管理与政策。

刘中全（1988—），男，河南周口人，国家发展和改革委员会创新驱动发展中心副研究员。主要研究方向：科技政策、生物经济。

1 引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》[1]提出健全医疗、医保、医药协同发展和治理机制，优化创新药审评审批，并健全医保支持创新药的机制。2025 年《支持创新药高质量发展的若干措施》[2]推动研发、准入与使用衔接；同年发布的首版商业健康保险创新药品目录自 2026 年 1 月起实施[3]。在创新药从获批上市到支付准入、临床使用的过程中，各环节如何理解和使用已有评价结论，成为政策协调的重要问题。

上述政策为跨环节衔接提供了制度安排，但不同部门对创新药的评价并不完全相同。一款创新药从获批上市、纳入医保到临床使用，涉及国家药品监督管理局（以下简称药监局）、国家医疗保障局（以下简称医保局）、国家卫生健康委员会（以下简称卫健委）的管理职责和评价安排，各环节的评价目的与参照对象各有侧重。课题组的专家访谈显示，药监局认定的一类创新药，未必能够满足医保局对临床价值的评审要求；纳入医保目录的药品，在医疗机构实际使用中仍可能面临障碍。因此，有必要进一步明确各环节评价所要解决的问题，以及评价结论可供其他环节参考的范围。

本文从两个层面比较三部门的创新药评价：一是根据安全性、有效性、经济性、创新性、公平性的注意力占比，考察各部门政策文本的关注重点；二是结合政策条文与访谈资料，比较同一维度下的评价对象、参照方案和决策用途。前者分析各部门如何分配对五维评价内容的关注，后者考察已有评价结论在后续环节的使用条件。

本文围绕三个问题展开：三部门的五维注意力配置有哪些异同；同一评价维度在不同环节对应哪些具体要求；哪些证据和信息需要跨环节衔接。为此，本文以“制度逻辑—组织注意力”为分析框架，对 2017—2026 年三个部门的 51 个政策来源条目进行编码，并结合政策条文、专家访谈与国际研究讨论协调路径。

2 文献综述

2.1 创新药多维评价的研究脉络

在评价标准与准入机制方面，孔繁翠[4]比较英、德、法、加四国的创新药价值评估制度，建议建立附加临床收益评估及分级体系；赵华婷等[5]借鉴法国经验，建议以临床价值分级及再评价支持

医保目录动态调整。段晓托等[6]在2017年的政策分析中指出，当时创新药医保准入存在遴选依据不够客观、等待时间较长和谈判机制不健全等障碍。艾丹丹等[7]讨论价值评估的多维属性，强调以公开透明的评价标准支持基于价值的定价和支付。

在主体互动方面，康姗姗等[8]、张新鑫等[9]、谭清立等[10]以及王恩楠等[11]分别围绕药品上市与经营、价格管制和创新激励、医保谈判，在各自的模型设定下分析利益、政策及信息条件对主体策略选择的影响；王恩楠等还结合三种谈判药品的销售资料进行比较。在政策与制度层面，吕倩鹏等[12]对65份国家层面创新药研发政策的量化分析发现，政策工具的内部结构存在失衡；毛心仪等[13]分析药品研发外部激励与内部治理的制度失衡，提出强制性与诱致性制度变迁建议；杨钰婷等[14]比较省级国谈药品单独支付政策，发现各地在目录管理、药品管理、保障待遇及政策衔接等方面存在差异。

国际研究表明，比较评价结论时，需要注意评价口径的差异。Casilli等[15]以2017年7月至2022年12月在意大利申请创新性认定的189个药品/适应症为样本，比较法、德、意三国健康技术评估（Health Technology Assessment，HTA）结论：德法一致率为82%，意法和意德分别为52%和57%；次级分析纳入意大利创新性认定中的证据质量因素后，意法和意德的一致率分别升至72%和74%。Garau等[16]对意大利19名患者代表、临床医生和支付方人员开展探索性研究，发现患者代表较重视疾病严重性与治疗获益类型，临床医生较重视疾病严重性与比较疗效，支付方人员较重视未满足需求、比较成本及证据质量。Kesselheim等[17]指出，对药物创新趋势的判断取决于如何定义创新；Monleón等[18]在欧洲五国HTA审议综述中归纳了伦理、文化、功能角色等七类隐性因素。

2.2 多主体评价差异的既有研究

Kållberg等[19]围绕抗生素研发与评价，收集了欧洲及美国药品监管和HTA机构19名参与者的访谈或书面答复。研究发现，受访者对新颖性的理解涉及新类别中的首个抗生素、无已知耐药机制等不同标准；临床数据有限，也给上市评价、HTA与临床使用之间的证据衔接带来困难。Mundy等[20]基于HTAi亚洲政策论坛背景论文与讨论指出，HTA对创新的定义和评价并不一致，创新因素往往隐含在优先排序及药品定价、报销决策之中。Janssens等[21]综合IMI PREFER项目的文献综述、访谈与焦点小组研究，提出患者偏好信息可为监管评价中的未满足需求、临床终点及获益风险权衡提供

参考；Mountford 等[22]在高等教育与医疗领域研究的综述中，讨论医学专业逻辑与市场—管理逻辑之间的张力及协调条件。

在国内研究中，李梦颖等[23]运用制度逻辑理论分析医保谈判药品的落地问题，讨论国家逻辑、市场逻辑、社会逻辑和专业逻辑之间的冲突与联系，重点关注谈判药品在医疗机构的落地。利益相关者视角[24]为识别不同主体及其利益联系提供了参照。本文关注药品监管、医保准入和临床使用中的评价判断，重点考察各环节的评价内容、参照对象和证据用途，并结合政策条文及其适用条件加以分析。

2.3 既有研究与本文定位

已有研究从政策工具视角比较医保局与卫健委的政策文本[25]，并归纳医保目录专家评审的五维价值框架[26]。在此基础上，本文聚焦三部门药品评价政策，比较各部门对同一价值维度的关注比重，以及不同维度在同一句段中的共同出现情况。依据统一标准进行句段编码，可以识别部门间的差异；结合条文和访谈，进一步分析这些差异与评价条件、使用环节的关系，从而明确跨环节衔接需要传递的评价信息。

3 理论基础与分析框架

3.1 核心概念与理论逻辑

政府注意力研究通过正式政策文本的内容选择，考察组织关注的重点[27]。文宏[28]通过关键词所在句段及其语境测量基本公共服务注意力；陈星平等[29]按同句同维计一次、跨维分别计数的原则，比较关注内容的构成；练宏[30]讨论组织与制度环境对注意力配置的影响。本文将“注意力配置差异”具体界定为三部门对五维评价内容的关注比重差异，并以“注意力占比”加以衡量，即某维度的编码句次占该部门五维编码句次总数的比例。同一句段可涉及多个维度，同维至多计一次，五维注意力占比合计为 100%。

Thornton 等[31]的制度逻辑视角强调实践、价值和规则与认知、行动及制度环境之间的联系；Greenwood 等[32]讨论组织如何回应多重制度要求。本文据此考察药品注册、医保准入和临床使用各自的决策目标，并比较这些目标在评价对象、证据要求和结论用途上的具体体现。

Ocasio[33]的注意力基础观认为，组织决策与其关注的议题及应对方案有关，注意力配置则受情境、规则、资源和关系等因素影响。陶鹏等[34]通过政府公开批示分析议题分配，李梦颖等[23]将制度逻辑与医药政策主体的注意力配置联系起来。本文据此考察三部门政策文本关注哪些评价内容，再结合条文与访谈分析这些关注与决策任务的关系。注意力占比用于衡量政策文本中的关注结构；实际评审中各维度的权重，则需依据相应的决策资料分析。

3.2 三种制度逻辑的操作化

借鉴李梦颖等[23]的医药政策分析，本文根据三部门核心文件的政策目标概括其制度逻辑。《药品注册管理办法》[35]要求保证安全、有效和质量可控，并明确临床价值导向，对应科学—安全逻辑；《基本医疗保险用药管理暂行办法》[36]（以下简称《暂行办法》）要求提高基金使用效益，将临床必需、安全有效、价格合理列为目录准入条件，对应经济—效率逻辑；《药品临床综合评价管理指南（2021 年版 试行）》[37]（以下简称《管理指南》）强调保障基本用药供应、规范使用及满足用药需求，对应公共服务逻辑。本文以这三种逻辑为比较依据，安全有效和临床价值则是三部门共同关注的基础（表 1、图 1）。

表 1 创新药评价中的三种制度逻辑

Table 1 Three Institutional Logics in Innovative Drug Evaluation

制度逻辑	对应部门	政策目标	评价要求	比较问题
科学—安全逻辑	药监局	保证安全、有效 和质量可控	以临床价值为导向； 提供相应证据	证据如何支持 上市决策
经济—效率逻辑	医保局	提高基金使用效益	临床必需、安全有效、 价格合理	评价结论如何用于 准入和支付
公共服务逻辑	卫健委	保障供应、规范使用， 满足用药需求	安全性、有效性、经济性、 创新性、适宜性、可及性	综合评价如何 指导临床使用

资料来源：作者整理。

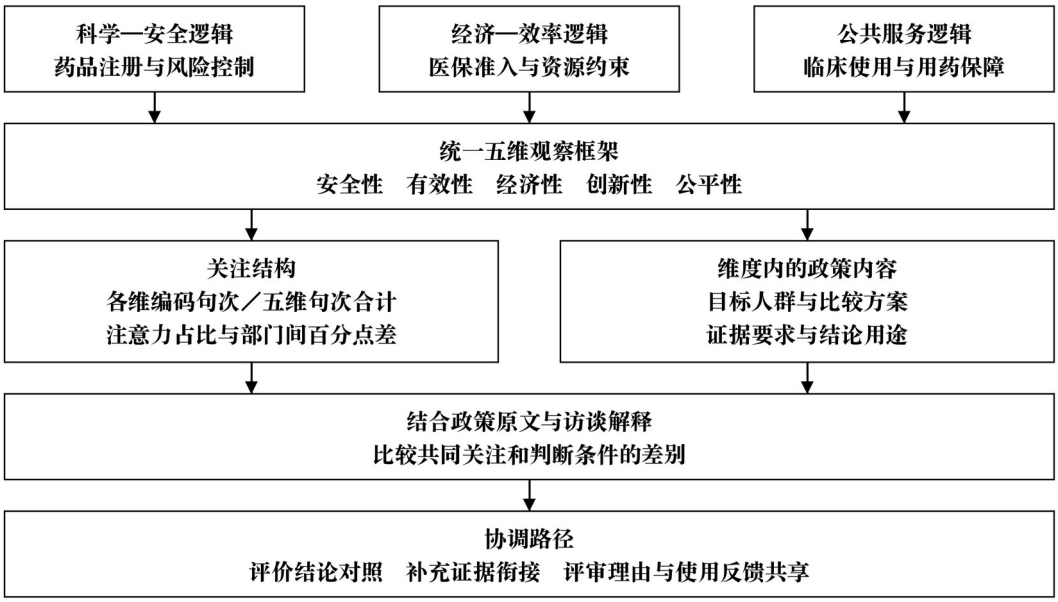


图 1 “制度逻辑—组织注意力”分析框架

Figure 1 The “Institutional Logics–Organizational Attention” Framework

资料来源：作者绘制。

3.3 变量与指标定义

本文将安全性、有效性（疗效与临床获益）、经济性、创新性、公平性分别记为 S、E、Ec、I、F，在句段层面逐维编码：符合该维定义记为 1，不符合记为 0，信息不足而无法判断时保留待定；同一句段可以涉及多个维度。五维的含义及纳入、排除条件见第 4.1 节和附录 A。部门用于分组，编码方法用于区分测量方式，均不作为新的价值维度。

本文从关注重心、内容覆盖和内容组合三个方面比较部门差异。第一，注意力占比以本部门某一维度被编码为 1 的句段数为分子，以五个维度被编码为 1 的句段数之和为分母，反映该维度在全部关注内容中的相对份额。同一句段涉及多个维度时，分别计入各维，五维占比之和为 100%。第二，内容覆盖比例以涉及某一维度的句段数除以本部门全部分析单元数，反映该类内容的出现范围；由于不同维度可以出现在同一句段中，各维比例之和不必为 100%。第三，条件比例反映两类内容在同一句段中出现的情况。例如，计算安全性句段中同时涉及有效性的比例时，分子为同时涉及两维的句段数，分母为涉及安全性且两维均可判定的句段数。若以有效性句段为分母，回答的则是另一问题：讨论疗效时，有多少句段同时涉及安全性。两类内容为何出现在同一句段中，结合政策原文及访谈解释；比较结果是否受来源构成、汇总方式和待定信息影响，则通过相应检验判断。

4 研究设计

4.1 政策文本与编码方案

研究范围为2017年至2026年7月公开的药品评价政策及配套官方材料。2017年，人力资源社会保障部组织药品谈判并将36种药品纳入医保目录乙类范围[38]，本文以此次目录纳入为观察起点。

参考吕倩鹏等[12]的政策筛选方法，收集药品监管、医疗保障和卫生健康系统的正式文本，剔除纯药品清单、年度审评报告、按疾病诊断相关分组和按病种分值付费的技术规范、逐年临床用药手册，以及已有正式版的征求意见稿。三部门比较共纳入51个来源条目，其中药监局17个、医保局24个、卫健委10个；党中央、国务院或两办发布的4份文件作为共同制度背景。一个来源条目可以包括通知、附件或配套官方问答，同一正文重复发布时只计一次。联合发文按既定的制度系统归属计入一个部门，并通过剔除联合文本检验这一处理对结果的影响。

本文采用医保目录调整中的安全性、有效性、经济性、创新性、公平性五维框架进行比较。《目录调整申报指南》[39]要求按这五个维度组织材料，2023—2026年沿用相同的维度名称，并对具体要求作出调整；《常用问答（2026年版）》[40]也要求从多个维度综合研判药品价值。各维申报内容依次涉及安全性信息、不良反应及同类药比较，疗效比较与指南推荐，价格费用及基金影响，创新点、临床优势、知识产权与注册分类，以及目录短板、临床管理难度等。公平性栏目还要求目录外药品提供价格费用信息，说明政策栏目的划分并不意味着研究中的各类内容相互排斥。因此，编码以句段的实质内容和统一操作定义为依据。

五维框架用于统一比较尺度，具体编码仍取决于句段表达的内容。《管理指南》[37]原设安全性、有效性、经济性、创新性、适宜性、可及性六个维度；其中涉及药品获取保障和可负担性的内容归入本研究的公平性，适宜性则按原政策含义解释。医保公平性栏目中的价格信息，按费用内容编码为经济性；若同时涉及患者负担或药品获取保障，则另记为公平性。各维度的纳入、排除及多标签编码规则见附录A。

本文采用自动规则编码与大语言模型编码（large language model coding，以下简称LLM编码）处理全部文本，并通过人工核验样本检验编码质量。自动规则编码结合领域词典和语境规则，判断

表述是否针对药品，辨明适用范围、上级条款及否定关系；LLM 编码依据完整手册，结合待判句段和必要上下文给出五维判断及原文依据。词典分类的任务验证参照 Kroon 等[41]，LLM 编码参照 Gilardi 等[42]及 Halterman 等[43]。两种方法使用同一版政策原文及必要上下文，遵循相同的五维定义和纳入、排除条件。

本文以具有完整政策含义的句段为分析单元，并保留上级条款、表头及前后文，以确定表述对象和适用条件。三部门共 4 481 个分析单元，其中药监局 1 848 个、医保局 2 100 个、卫健委 533 个。参考 Card 等[44]允许同一文本体现多个框架的标注思路，采用多标签编码：五个维度分别作 0/1 判断，信息不足者保留待定；同一句段在同一维度至多计一次，可以同时计入不同维度。例如，“降低患者用药负担”既涉及费用，也涉及患者可负担性，可同时编码为经济性和公平性；降低企业申报费用则不据此编码为公平性。各维度依据具体含义分别判断，不因出现在同一段落中而一并赋值。注意力占比按第 3.3 节计算，部门差异以百分点表示。两种方法的全量结果并列报告，考察其共同显示的部门差异，并结合人工核验和政策语境解释分歧；另抽取 200 条进行人工核验，在同一样本上比较两种方法。

4.2 编码质量检验

固定编码方案后，从此前未用于调整编码规则的 1 151 条材料中抽取 200 条进行人工核验。抽样时，将至少被一种机器方法判为涉及创新性或公平性的 39 条材料全部纳入，其余 1 112 条按部门分层，采用简单随机不放回抽样抽取 161 条。最终样本包括药监局 117 条、医保局 71 条和卫健委 12 条。经 AI 辅助初评后，研究者依据统一手册对照原文核验，确认 18 项初评分歧，形成 200 条材料、1 000 项五维判断的人工核验参照，所有判断均为 0/1 结果。

依照任务验证原则[45]，分别比较自动规则编码、LLM 编码与人工核验参照的结果，计算 Cohen κ[46]和观察一致率，并参照 Kristensen-McLachlan 等[47]报告精确率（P）、召回率（R）及 F1。各维度均以标签 1 为正类：P 反映机器判为 1 的句段中有多少得到人工核验确认，R 反映人工核验判为 1 的句段中有多少被机器识别，F1 为两者的调和均值。总体四格及分类指标按维度报告，并按各层入样概率的倒数加权，估计范围为 1 151 条抽样框。近似 95%区间采用分层重标 bootstrap 方法[48]计算：

在非全查层内重采样并作有限总体校正，全查层权重保持为 1；重复计算 5 000 次，取 2.5%与 97.5%分位数作为区间端点。

κ 用于衡量扣除机会一致后的判定一致性。κ=1 表示两套判定完全一致，κ=0 表示与按边际比例计算的机会一致相当，负值则表示低于机会一致。P、R、F1 取值为 0—1，数值越大，表明机器判断与所用参照越吻合。本文结合各维度的四格、分类指标及区间，分析编码结果与人工核验结果的差异。

表 2 两种编码方法相对于人工核验参照的设计加权分类指标

Table 2 Design-Weighted Classification Metrics against the Human-Reviewed Reference

维度	编码方法	κ	P	R	F1
安全性	自动规则编码	0.705	0.929	0.608	0.735
安全性	LLM 编码	0.895	0.909	0.908	0.908
有效性	自动规则编码	0.697	1.000	0.547	0.707
有效性	LLM 编码	1.000	1.000	1.000	1.000
经济性	自动规则编码	0.672	0.752	0.664	0.705
经济性	LLM 编码	0.966	0.941	1.000	0.970
创新性	自动规则编码	0.420	0.818	0.290	0.429
创新性	LLM 编码	0.936	0.938	0.938	0.938
公平性	自动规则编码	0.304	0.800	0.191	0.309
公平性	LLM 编码	0.788	0.938	0.684	0.791

注：表中为 200 条样本按抽样设计加权后的点估计，保留 3 位小数，估计范围为 1 151 条抽样框。两种方法均与同一人工核验参照比较，各维度以标签 1 为正类，P、R、F1 取值为 0—1；分母为零或指标无法定义时记为 NA。机器判定为待定的项目不作 0 处理，各项指标使用相应方法、相应维度可作二元判断的样本。原始四格、待定数量、原始 κ 与 F1，以及加权指标的近似 95%区间见附录 C。

在 200 条核验样本的原始对照中，LLM 五维 κ 为 0.914—1.000，P、R 和 F1 为 0.909—1.000（见附录 C）。按抽样设计加权后，LLM 在安全性、有效性、经济性和创新性上的 κ 为 0.895—1.000，F1 为 0.908—1.000；公平性的 κ 和 F1 分别为 0.788 和 0.791。两种编码方法的完整加权结果见表 2，

公平性分歧的权重解释见附录 C。部门注意力分布依据全量编码比较，并进一步考察来源构成、汇总方式及待定信息对结果的影响。

内容核查将政策原文、五维定义和句段判断相互对照，重点区分药品与行政事务、实质创新与名称提及、公平保障与一般程序[28-29]。结合原文和访谈，进一步辨明评价对象、比较方案以及评价结论的用途。

除检验编码质量外，200 条人工核验样本还用于比较人工核验与两种机器编码的注意力分布。先按入样概率的倒数加权，估计各维度已判为 1 的句次数，再除以五维相应句次之和[49]。这一分布的估计范围为 1 151 条抽样框，结果见附录 C。三部门全部 4 481 条材料的分布，则分别依据两种机器方法的全量编码计算。内容覆盖比例、注意力占比及维度间条件比例的定义见第 3.3 节。

表 3 全语料三部门五维注意力占比

Table 3 Full-Corpus Five-Dimensional Attention Shares by Department

部门	方法	安全性（%）	有效性（%）	经济性（%）	创新性（%）	公平性（%）
药监局	自动规则编码	38.12	25.80	0.72	24.64	10.72
药监局	LLM 编码	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
医保局	自动规则编码	6.34	6.84	78.20	6.21	2.41
医保局	LLM 编码	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
卫健委	自动规则编码	43.02	16.28	29.07	5.81	5.81
卫健委	LLM 编码	39.37	16.54	28.35	3.94	11.81

注：两种方法均覆盖三部门 4 481 个分析单元，其中药监局 1 848 个、医保局 2 100 个、卫健委 533 个。注意力占比以百分数表示，分母为相应方法在本部门五个维度判为 1 的句次之和；同一句段可计入多个维度，同一维度至多计一次。规则编码与 LLM 编码分别有 242 项和 60 项维度判断待定，均不作 0 处理，表中占比按已判为 1 的结果计算。未舍入的五维占比之和为 100%，表中保留 2 位小数，分别舍入后合计可能略偏离 100%。

4.3 访谈资料与解释用途

访谈及研讨材料包括 3 场研讨会材料、史录文教授访谈纪要和医保局调研纪要，用于理解评价内容所处的决策情境。药品监管环节主要依据公开技术文件，研讨会材料用于补充跨环节衔接问题。参照 Carter 等[50]的多来源对照方法，将纪要中的陈述与政策条文对照分析。

围绕评价对象、证据要求、结论用途和跨环节实施问题整理资料，注明各项陈述所涉及的评价环节，并回查相应政策。纪要中有关支付准入、医院配备和临床使用的内容，用于解释不同环节的衔接问题；存在不同意见时，保留各自判断所依据的条件。具体引文、日期及来源位置列入配套证据索引。

5　政策文本比较分析

5.1　三部门的注意力配置差异

三部门在五个维度上的关注重心有所不同（表 3、图 2）。自动规则编码显示，药监局安全性、有效性、经济性、创新性、公平性的注意力占比分别为 38.12%、25.80%、0.72%、24.64%、10.72%；医保局分别为 6.34%、6.84%、78.20%、6.21%、2.41%；卫健委分别为 43.02%、16.28%、29.07%、5.81%、5.81%。从这一分布看，药监局较多关注风险和疗效证据，医保局突出经济价值与支付安排，卫健委则以安全性和经济性内容占比较高。

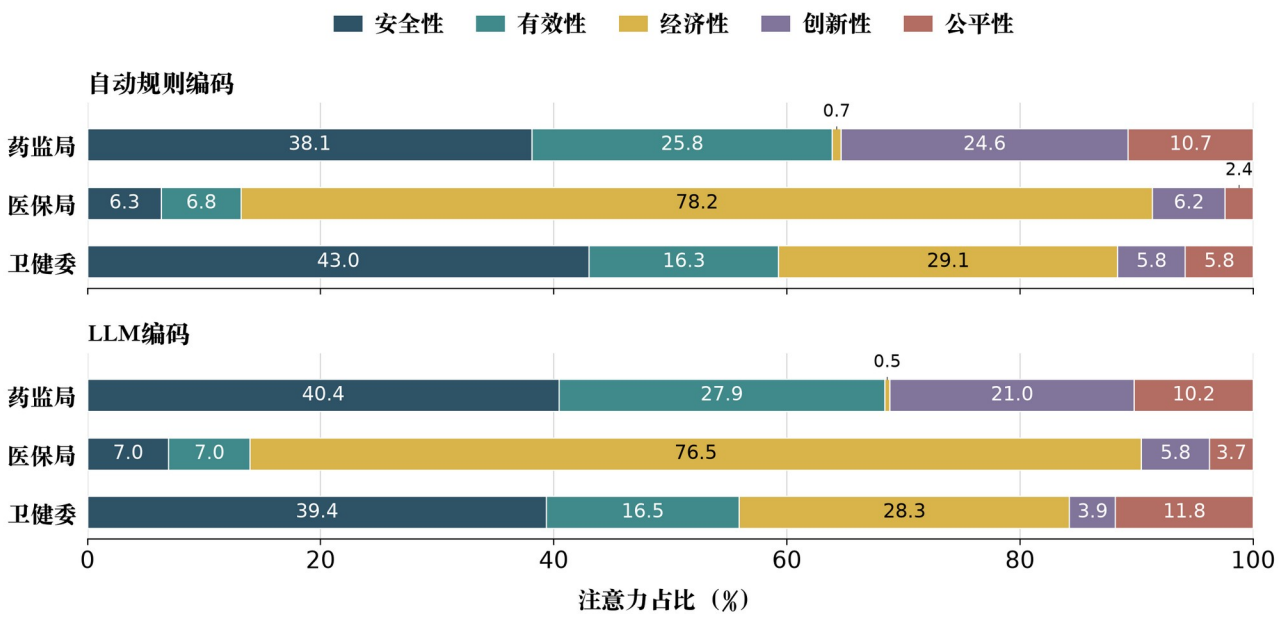


图 2 三部门五维注意力占比分布

Figure 2 Five-Dimensional Attention Shares in the Three Departments

注：两种方法使用同一政策语料。各部门的注意力占比以相应方法在五个维度判为 1 的句次之和为分母，待定判断另行保留。同一句段可计入多个维度，同一维度至多计一次；未舍入的五维占比之和为 100%。图中保留 1 位小数，完整数值及编码覆盖情况见表 3。

将三个部门两两比较，共形成 3 组部门配对；每组比较 5 个维度，共有 15 项占比差异。其中，自动规则编码与 LLM 编码有 13 项比较的方向一致。方向不同的两项均出现在药监局与卫健委之间：

安全性占比在自动规则编码中分别为 38.12%、43.02%，在 LLM 编码中为 40.44%、39.37%；公平性占比分别为 10.72%、5.81%和 10.20%、11.81%。按全部句段统计，两种方法均显示，药监局的有效性和创新性占比最高，医保局的经济性占比最高；安全性和公平性占比最高的部门则随编码方法而变化。

注意力占比不仅取决于某一维度的编码句次，也取决于五维句次的总和。以药监局安全性为例，自动规则编码为 263/690（38.12%），LLM 编码为 440/1 088（40.44%）；医保局经济性则分别为 617/789（78.20%）和 878/1 148（76.48%）。前一例中，LLM 识别的安全性句次更多，占比也更高；后一例中，LLM 识别的经济性句次虽更多，占比却更低。九种统计口径下，两种方法均显示医保局经济性占比高于卫健委。药监局内部以安全性居首、医保局内部以经济性居首，在九种口径及逐一剔除各自部门的政策来源后均保持不变；卫健委按全部句段统计时以安全性居首，剔除联合来源后，两种方法均显示经济性居首。这些分布反映的是所收集政策文本的关注重心。

逐句核对发现，两种方法的部分分歧来自对上下文的不同处理。例如，在临床综合评价六维评价要求的案例中，同一版文件将患者费用与家庭收入的关系纳入“可及性评价”。LLM 据此将概括性的六维评价要求同时编码为公平性，自动规则编码则未赋予这一标签。两者的区别在于，是否将同版文件中的具体可负担性定义用于解释该句段。其他核查案例还涉及优先审评共同条件的适用范围，以及流程描述是否体现按需优先配置资源的要求。具体原句、两种方法的标签及上下文依据，见附录 A 所述的配套方法差异记录。

5.2 五维关注的具体政策内容

经济性内容与公平性内容在同一句段中出现的情况，也存在部门差异。在两维均可判定的句段中，自动规则编码显示，卫健委 25 条涉及经济性的句段中有 1 条同时涉及公平性，即 1/25（4.00%）；医保局为 2/589（0.34%）。LLM 编码的对应比例分别为 5/36（13.89%）和 26/877（2.96%）。在 LLM 编码的九种统计口径及逐一剔除政策来源的比较中，卫健委的这一比例始终较高；规则编码在剔除联合来源或 2024 年基层药品联动来源后，则转为医保局较高。这一比例考察价

格、费用或支付内容中，有多少同时涉及患者获取药品的机会与负担；其政策含义还需结合具体条文解释（表 4）。

如果改以涉及公平性的句段为分母，比较的就是保障内容中有多少同时涉及费用。在自动规则编码中，医保局为 2/19（10.53%），卫健委为 1/5（20.00%）；在 LLM 编码中，两者分别为 26/43（60.47%）和 5/15（33.33%）。两种方法给出的部门排序不同，且都受到政策来源构成的影响。以经济性为分母，考察的是费用讨论中有多少同时涉及保障；以公平性为分母，考察的则是保障讨论中有多少同时涉及费用。两种比例由此揭示评价内容组合的不同侧面。

表 4 同一评价维度在三部门的具体内容

Table 4 Policy Content within Each Evaluation Dimension across the Three Departments

维度	药监局	医保局	卫健委
安全性	研发和上市环节的药物风险、获益风险评价及控制措施	同类药安全性比较及药品保障渠道中的用药安全	上市前后的安全性证据、处方风险与合理用药
有效性	目标患者的临床获益、试验对照与终点	与试验对照及目录内同领域药品比较，明确支付人群	与参比药比较实际人群的健康获益，必要时开展亚组分析
经济性	真实世界经济学效益评价、试验供药及检测费用的承担	价格、治疗费、支付范围内费用、基金影响与续约	用于采购和临床资源配置的增量经济分析
创新性	注册创新分类、临床价值导向及研发支持	创新带来的疗效与安全性优势、产品属性变化	临床需求的满足、治疗空白的填补及自主研发
公平性	优先审评临床急需短缺药品，回应供药需求	目录保障短板、患者获取药品的机会及供应、支付条件	机构药品配备、短缺情况、可获得性与家庭可负担性

资料来源：药品注册管理办法[35]、医保用药管理及申报材料[36,39-40]、临床综合评价指南[37]及对应技术文件；逐格条款、页码与原文证据见配套政策证据矩阵。

药监局有关安全性和有效性的政策内容，主要围绕药品研发及上市所需的获益风险证据展开。《创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）》[51]要求识别影响获益风险平衡或受试者安全的风险，并制定预防、监测和治疗措施；抗肿瘤药物研发指南[52]则强调试验对照选择与患者获益终点之间的联系。两种编码方法均显示，经济性在药监局的注意力占比中较低，其具体内容包括真实医疗实践中的经济学效益评估[53]，以及 2026 年发布的《药物临床试验质量管理规范》[54]第四

十五条规定的免费供药及医学检测费用责任。公平性内容则包括《药品注册管理办法》[35]第六十八条对临床急需短缺药品作出的优先审评安排。

医保局的经济性评价涉及药价、治疗费用、销量预测、支付范围和基金影响。《申报指南》[39]要求报告未来两年的销量与基金影响，《谈判药品续约规则》[55]依据实际药品费用与预算的比值安排续约和支付标准调整。2025 年官方问答将基金支付监测与可及性联系起来，并说明支付标准包含基金和参保人员共同支付的费用[56]，体现了费用评价与保障安排之间的联系。卫健委《管理指南》[37]将价格水平、可获得性和可负担性共同纳入可及性评价，要求必要时结合医保报销判断患者实际支付水平，并以年用药治疗费用占家庭年可支配收入的比重衡量可负担性；药品监测政策[57]进一步要求共享信息、保障供应并应用评价结果。由此可见，经济性与公平性的联系具体表现为费用保障、药品供应和临床使用等问题。

在讨论药品安全性的句段中，医保局更常同时涉及疗效，两种编码方法均显示其相应比例高于药监局和卫健委。以自动规则编码为例，医保局 49 条涉及安全性且两维均可判定的句段中，有 32 条同时涉及有效性，占 65.31%；药监局和卫健委的对应比例分别为 99/262（37.79%）和 9/37（24.32%）。在 LLM 编码中，医保局、药监局、卫健委的比例分别为 64/79（81.01%）、187/439（42.60%）和 13/50（26.00%）。九种统计口径及逐一剔除来源的比较均显示，医保局的这一比例高于药监局。与卫健委相比，LLM 编码始终显示医保局较高；规则编码在剔除联合来源后，两者同为 66.67%，其余口径及逐一剔除来源的比较仍显示医保局较高。《暂行办法》第七条将安全有效、临床必需和价格合理共同列为目录准入条件[36]，《申报指南》要求说明创新带来的疗效或安全性优势[39]。医保局调研纪要也将安全性、有效性和经济性列为综合评审的核心内容。安全性在医保局五维关注中的相对份额较小，但在涉及安全性的讨论中，疗效内容更常一并出现；相关条款也将安全有效共同用于准入及价值比较。

5.3 评价判据与参照对象

要衔接不同环节对同一维度的评价，还需核对评价人群、比较方案和证据用途。条文与访谈表明，创新身份、临床获益和支付价值的判断各有条件。

关于创新性，《化学药品注册分类及申报资料要求》[58]同时考察化合物新颖性和临床价值，《药品注册管理办法》[35]强调以临床价值为导向支持药物创新。医保局的申报材料须说明创新带来的疗效或安全性优势[39]，续约规则则将 1 类药注册身份用于特定条件下的谈判选择[55]；《管理指南》[37]通过药品与参比药的比较，考察满足临床需求的程度，并关注治疗空白、未满足需求及自主研发。三部门都重视创新的临床意义，但评价结论分别用于分类注册与研发支持、支付决策或临床配备。医保局调研纪要指出，获得创新注册分类并不意味着能够实现企业预期的谈判价格，也说明了这些判断用途的区别。

在有效性和证据要求上，抗肿瘤药物研发指南[52]要求阳性对照反映目标患者在临床实践中的最佳治疗选择；医保局《申报指南》[39]要求比较试验对照药品及目录内同治疗领域药品，《常用问答》[40]进一步明确，参照药原则上应为临床应用最广泛的同治疗领域、同作用机制的目录内药品；《管理指南》[37]重视参比药、最佳可得研究证据及真实世界数据，必要时开展亚组分析。因此，使用既有研究结果时，应在同一人群和治疗线别下，核对试验对照、医保参照药和临床参比药的异同及适用条件，据此判断原有证据能否直接使用，或是否需要补充比较。

在价值衡量上，药监局通过获益风险判断支持上市审批和风险控制，医保局通过比较价值、价格费用及基金影响评估支持医保准入与支付，卫健委则通过安全性、有效性及增量经济分析支持医疗机构的药品遴选、采购使用和资源配置[35-37]。高校药事管理领域的受访专家强调，医保评审应从健康需求出发；医保局调研纪要也讨论了临床价值分层与经济评价的衔接。结合政策条文可见，经济评价方法虽可用于不同环节，但各项评价仍需分别说明分析视角、成本范围、适用人群和决策责任。

5.4 制度逻辑的解释

从制度逻辑看，药监局的科学—安全逻辑体现为研发和上市环节对获益风险及证据充分性的重视；医保局的经济—效率逻辑体现为公共支付中对比较价值与资源约束的关注；卫健委的公共服务逻辑则体现为对安全合理用药、药品供应和临床需求的重视。五维注意力占比反映了各部门的关注重点，不同维度在同一句段中的组合则说明，各部门如何将这些要求纳入具体评价。安全性与有效

性、经济性与公平性的组合，以及相关准入、支付和供应条文，为理解评价任务与关注内容之间的关系提供了依据。

从注意力基础观看，三部门都关注安全性、有效性及临床价值，各类内容所占的比重及其组合也随决策任务有所不同。医保局的申报要求引用药审技术评审报告[39]，说明上市审评证据可以为后续评价提供依据；卫健委同时评价价格与药品获取情况[37]，将支付条件、医疗机构配备和临床使用联系起来。2025 年 6 月 9 日史录文教授访谈纪要中的“医保进了，医院不一定用”，也说明药品纳入医保后，仍需解决进入医疗机构和用于临床的问题。

因此，跨部门协调需要明确评价结论的适用条件：针对同一人群核对参照方案，说明已有证据能够回答哪些问题，并共享支付范围、患者负担、医疗机构配备和实际使用信息。后续环节据此判断哪些结论可以直接参考、哪些问题需要补充研究；支付和临床使用中的反馈，则可为下一轮评价提供依据。

6 协调路径与政策建议

上述分析表明，跨部门协调既要明确各项评价结论的适用条件，也要解决支付、供应和临床使用之间的衔接问题。结合我国现有的沟通机制、评价安排和药品目录实施要求，本文提出以下建议。

6.1 在参照药预沟通中对照评价结论

三部门都关注临床价值，但试验对照药品、医保参照药和临床参比药用于不同的评价任务。建议先对符合参照药预沟通条件的品种，按药品通用名、适应症、目标人群和治疗线别编制评价结论对照单，由企业随现有申请材料提交。对照单分别列出药监局审评报告中的主要终点、获益风险、批准条件和证据截止日，医保参照药及支付范围，以及临床指南中的推荐使用位置。对于人群、参照药品或终点不同的研究，应说明结果能否用于当前评价及其依据，并列明需要补充的证据。对照单可沿用现有申请表及附件内容，补充参照差异、证据适用条件和开展补充研究的理由。

2026 年 2 月实施的《参照药预沟通办法（试行）》[59]已提供前置沟通渠道，医保局申报指南[39]也要求提供药审技术评审报告。医保局可在现有论证和企业反馈过程中试用评价结论对照单，以药监局公开的审评信息和医疗机构专业意见为依据，并在正式目录评审或新增适应症后更新。2026 年

药品价格政策[60]区分创新类别并强调临床价值，对照单可据此分别说明注册创新分类、比较获益和支付评价所依据的证据，减少重复提交材料及参照药品不一致带来的问题。

6.2 依托现有评价点衔接补充证据

药监局侧重获益风险证据，医保局侧重比较价值及费用影响，卫健委侧重临床使用与供应，补充研究应分别回应这些需要。建议先选择已有明确上市后研究义务或支付评价证据不足的品种，由企业、专业评价团队和参与医疗机构共同拟订补充研究计划，明确研究人群、参照药品、终点、随访期限、数据来源及质量控制要求。可以共用的临床数据按统一字段采集，药物警戒、医保价值评价和临床综合评价仍分别依据各自的目的开展研究设计与分析，并说明结论的适用范围。

《药品注册管理办法》[35]第六十六条已规定附条件批准药品的研究义务。2025 年真实世界医保综合价值评价试点通知[61]提出，2026 年建设数据库、开展评价并形成初步成果；2026 年 1 月，首批国家可信评价点网络已组建[62]。试点地区医疗保障部门可协调具备相应专科能力的可信评价点参与补充研究。上市许可持有人履行法定的上市后研究义务，其他评价任务按项目约定分工，参与医疗机构负责数据质量和随访。研究开始前，应按照各环节的要求，明确注册研究报告、医保续约及机构药事管理所需结果的提交时间，并记录证据更新情况。

2026 年医保局官方解读[63]区分了医保价值评价与药物警戒、附条件上市确证性试验及临床综合评价的用途。因此，补充研究应针对各环节的问题分别分析；即使共用数据，也应保留人群、费用口径和参照药品的差异。意大利药品管理局（AIFA）监测登记中的按结果支付安排[64]以及国际上的药品目录退出经验[65]可为试点提供参考。在国内既有协议和支付权限内，应先明确评价结果如何用于续约或管理调整，再讨论相应的费用责任，使新增证据能够用于后续决策。

6.3 完善目录药品获取与使用反馈

全量语料的主口径分析显示，医保局对经济性的关注占比高于卫健委；而在涉及经济性的表述中，卫健委同时涉及公平性的比例高于医保局。相关条文分别关注费用保障、医疗机构药品供应和临床使用。2025 版双目录通知[3]已要求定点机构原则上于 2026 年 2 月底前召开药事会，并明确药品配备、临时采购和监测责任。建议在现有报送内容中增加药品未配备或患者无法使用的原因，区分

无适用患者、证据或用药条件不足、供应延迟和支付衔接等问题。医疗机构药学部门核对临床需求与采购状态，省级卫生健康部门协调医疗机构面临的问题，医疗保障部门处理支付范围及协议执行问题，企业反馈供应情况。

依托既有药品配备查询和省级信息报送渠道，可按药品及适应症汇总配备状态、采购进度、获取渠道和费用保障信息。对于临床急需但尚未常规配备的药品，符合条件的可按现有临时采购或双通道规则处理，并反馈解决情况。基本医保药品应注明支付范围和个人负担条件；商保创新药目录中的药品须由保险机构确认具体产品的保障责任，并另列患者自付条件，不能将纳入商保目录等同于基本医保报销[3]。个体资料应按授权和数据管理要求使用，保密价格信息按权限提供。通过补充现有报送字段、明确反馈责任，及时掌握药品纳入目录后患者能否实际获得和使用。

7　结语

本文以安全性、有效性、经济性、创新性和公平性为共同维度，比较药监局、医保局和卫健委创新药评价政策的注意力配置。两种编码方法的主口径结果均显示，药监局和卫健委对安全性的注意力占比最高，医保局对经济性的占比最高。在涉及药品安全的表述中，医保局同时讨论疗效的比例更高；经济性与公平性的共同出现情况则因编码方法和来源构成而有所不同。结合政策条文与访谈可见，这些差异与目录准入、患者费用负担、药品供应和临床使用等任务有关。各部门虽使用相同的评价维度，但评价对象、参照方案和结论的适用范围各有侧重。跨部门协调应据此明确已有结论的使用条件，在参照药预沟通中对照评价结论，依托可信评价点开展补充研究，并通过目录药品的使用反馈衔接支付保障与患者用药。后续可结合药品评审、医疗机构配备和患者使用资料，进一步考察政策文本中的注意力配置与实际执行效果之间的关系。

附录 A　编码规范与配套统计

安全性 S 包括药物损害、用药风险及其识别、评价和控制；涉及质量的内容须明确关联药物风险。有效性 E 包括防治效果、临床获益及相应证据。经济性 Ec 包括药品价格、费用、支付和成本效果。创新性 I 包括技术创新、实质改良及其资格评价，现有创新资格与实质权利义务之间的联系，以及明确的创新研发支持。公平性 F 包括对药品或患者治疗公平性的实质评价要求，或患者按治疗

需要获得、持续接受所需药品的机会和负担关系。临床管理难度、一般可及性或程序名称本身不构成公平性编码的依据。同一句段可计入多个维度，在同一维度至多计一次；一般名称、事务性程序及针对其他对象使用的同名词，不据此自动赋予标签。全文和必要上下文用于解释待判句段的对象、条件及引用内容。

为考察统计方式对结果的影响，设置九种口径：条款等权、来源内同年精确重复降权、部门年度内精确重复降权、剔除联合来源、剔除年度系列来源、剔除多组件来源、限定 2018—2025 完整自然年、来源等权均值及系列年度成员均值。此外，逐一剔除 51 个来源条目，比较总体及相关部门的五维计数、注意力占比和排序。待定判断不作 0 处理；在保持已观察二元标签不变的情况下，允许待定维度在 0 与 1 之间取值，计算注意力占比及正文所用条件比例的上下界。这些检验用于区分来源构成、汇总方式和待定信息的影响，完整分母及比较方向见配套统计。

LLM 编码请求的模型设置为 gpt-6.1-sol，推理强度为 ultra，依据完整手册给出五维判断。三部门主语料共 4 481 个分析单元，每批实际处理 1—12 条。各批次使用独立上下文，读取同一版原文及必要语境，不提供参考标签或机器预测结果。依 Törnberg[66]关于记录任务和提示的建议，完整手册、规则、提示词及输入输出记录均随研究资料保存；服务未提供的生成参数记为不可得。

配套材料包括统一编码手册、自动规则、提示词、机器输入输出及各维判定依据，以及 200 条样本的初评、人工核验结果、分歧确认记录和抽样权重。配套统计报告全量分布、两种机器编码之间的二元四格、待定数量、分歧案例，以及相对于人工核验参照的分类指标。对正文涉及的安全性与有效性、经济性与公平性组合，分别列出同时判为 1 的句段数、两维均可判定时的条件分母、待定数量及相应上下界，并报告九种统计口径和逐一剔除来源后的比较方向。

附录 B　政策来源范围

三部门主语料共 51 个来源条目、4 481 个分析单元。其中，药监局 17 个来源条目、1 848 个单元，医保局 24 个来源条目、2 100 个单元，卫健委 10 个来源条目、533 个单元。另有 4 个中央来源条目、443 个单元作为制度背景，不纳入三部门主比较。来源条目可以包括通知、方案、附件和官方问答，其完整名称、文号、实际发布机关及组件关系见配套来源清单。

官方问答与正文分别标记，重复附件只计一次。联合专业文件保留全部署名机关，并按既定制度系统归入一个部门。计算来源等权均值时，先求各来源内部的比例，再对相应分母非零的来源取均值；分母为零的比例保留为无定义。系列年度成员均值按已固定的系列和年份归属计算。200 条核验样本中，全查部分包括药监局 31 条、医保局 8 条；其余材料按部门分层，药监局、医保局和卫健委的层规模分别为 595、433、84 条，抽取 86、63、12 条，相应权重为 595/86、433/63、7，全查部分权重为 1。三部门 4 481 条全量分布、200 条人工核验资料及相应统计结果分别保存。

附录 C　编码质量检验

200 条人工核验样本中，安全性、有效性、经济性、创新性和公平性分别有 27、13、20、32、16 项判断为 1。表 C1 列出机器编码与人工核验参照未经加权的比较结果，抽样权重见附录 B。

表 C1 人工核验样本的原始对照

Table C1 Unweighted Comparison with the Human-Reviewed Reference

维度	方法	二元 N	待定	TP/FP/FN/TN	κ	F1
安全性	规则	198	2	14/1/11/172	0.669	0.700
安全性	LLM	199	1	25/2/2/170	0.914	0.926
有效性	规则	198	2	5/0/6/187	0.612	0.625
有效性	LLM	199	1	13/0/0/186	1.000	1.000
经济性	规则	198	2	13/4/7/174	0.672	0.703
经济性	LLM	199	1	20/2/0/177	0.947	0.952
创新性	规则	199	1	9/2/22/166	0.378	0.429
创新性	LLM	199	1	30/2/2/165	0.926	0.938
公平性	规则	199	1	4/1/11/183	0.377	0.400
公平性	LLM	199	1	15/1/1/182	0.932	0.938

注：TP 表示机器与人工核验均判为 1，FP 表示机器判为 1 而人工核验判为 0，FN 表示机器判为 0 而人工核验判为 1，TN 表示两者均判为 0。每行可作二元比较的样本数 N 与待定数之和为 200，技术失败数为 0。待定判断不纳入该维度的二元四格；按抽样设计加权后的指标见表 2。

表 C2 设计加权分类指标的近似 95%区间

Table C2 Approximate 95% Intervals for Design-Weighted Classification Metrics

维度	方法	κ	P	R	F1
安全性	规则	0.527–0.848	0.776–0.996	0.419–0.792	0.568–0.865
安全性	LLM	0.785–0.972	0.778–0.994	0.788–0.994	0.812–0.977
有效性	规则	0.332–0.925	—	0.206–0.864	0.341–0.927
有效性	LLM	—	—	—	—
经济性	规则	0.466–0.832	0.530–0.928	0.452–0.859	0.506–0.851
经济性	LLM	0.897–0.995	0.830–0.991	—	0.907–0.995
创新性	规则	—	—	—	—
创新性	LLM	0.936–0.936	—	—	—
公平性	规则	0.199–0.406	—	0.118–0.275	0.205–0.410
公平性	LLM	0.581–0.951	—	0.429–0.967	0.589–0.952

注：按分层抽样设计进行 5 000 次有限总体校正重抽样，各方法和维度使用同一组重复权重。“—”表示重抽样分布退化，因而不据此报告总体指标区间。区间反映核验结果固定时的抽样变化。LLM 创新性 κ 的区间上下限舍入后均为 0.936，未舍入的端点分别为 0.935 680 和 0.935 712。

LLM 在公平性上的原始四格包含 1 项漏判和 1 项误判。漏判所在层的权重为 595/86，误判位于全查层，权重为 1。由于两项分歧所代表的材料数量不同，加权召回率为 0.684，低于未经加权的 0.938；其近似 95%区间为 0.429—0.967。这一差别由抽样权重及分歧在各层的分布共同决定。

表 C3 同一样本的加权覆盖比例与注意力占比（%）

Table C3 Design-Weighted Coverage and Attention Shares in the Same Sample (%)

维度	人工 p	人工 q	规则 p	规则 q	LLM p	LLM q
安全性	13.15	39.28	8.50	38.59	13.15	39.07
有效性	4.73	14.12	2.49	11.31	4.73	14.05
经济性	10.92	32.61	9.64	43.78	11.61	34.48
创新性	2.78	8.30	0.96	4.34	2.78	8.26
公平性	1.90	5.69	0.43	1.97	1.39	4.13

注：内容覆盖比例 p 以 1 151 条抽样框为分母；注意力占比 q 以相应方法在五个维度已判为 1 的加权句次之和为分母。两种机器方法的待定判断另行保留。表中结果对应核验样本的抽样框，不与 4 481 条全量语料的部门分布合并。

参考文献

[1]中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[Z].2026.

[2]国家医疗保障局,国家卫生健康委员会.支持创新药高质量发展的若干措施(医保发〔2025〕16号)[Z].2025.

[3]国家医疗保障局,人力资源社会保障部.关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》(2025年)的通知:医保发〔2025〕33号[EB/OL].(2025-12-07)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_53_18971.html.

[4]孔繁翠.创新药价值评估的国际经验比较及启示[J].中国卫生政策研究,2022,15(6):17-23.

[5]赵华婷,颜建周,邵蓉.法国临床效益评价对我国创新药医保目录动态调整的启示[J].中国卫生经济,2019,38(5):94-96.

[6]段晓托,连桂玉,贾耀珠.我国创新药进入医保目录的障碍与对策[J].中国药房,2017,28(4):455-457.

[7]艾丹丹,陈辰,吴婷婷,等.价值医疗背景下创新药品的定价和支付模式综述[J].中国卫生经济,2020,39(3):77-79.

[8]康姗姗,胡霞,颜建周.药品上市决策中的多方利益博弈[J].中国药房,2010,21(21):1921-1925.

[9]张新鑫,侯文华,申成霖.价格管制、战略性创新激励与创新药市场绩效[J].科研管理,2017,38(10):68-75.

[10]谭清立,李永盈,崔洪瑞.创新药医保谈判的博弈分析[J].卫生经济研究,2024,41(6):5-9,15.

[11]王恩楠,朱铭来.我国专利药品医疗保险价格谈判的演化博弈研究[J].中国卫生政策研究,2023,16(2):44-51.

[12]吕倩鹏,吴红,刘智勇.政策工具视角下我国创新药物研发政策量化研究[J].中国卫生事业管理,2024,41(12):1393-1399.

[13]毛心仪,姚峥嵘.制度创新理论视角下我国药品研发制度变迁设计[J].卫生经济研究,2021,38(7):38-43.

[14]杨钰婷,胡婉慈,左根永.我国医疗保险国谈药品单独支付政策省际比较研究[J].中国卫生政策研究,2024,17(1):24-29.

[15]CASILLI G,LIDONNICI D,JOMMI C,et al.Do France, Germany, and Italy Agree on the Added Therapeutic Value of Medicines?[J].International Journal of Technology Assessment in Health Care,2023,39(1):e54.

[16]GARAU M,HAMPSON G,DEVLIN N,et al.Applying a Multicriteria Decision Analysis (MCDA) Approach to Elicit Stakeholders' Preferences in Italy: The Case of Obinutuzumab for Rituximab-Refractory Indolent Non-Hodgkin Lymphoma (iNHL)[J].PharmacoEconomics Open,2018,2(2):153-163.

[17]KESSELHEIM A S,WANG B,AVORN J.Defining "Innovativeness" in Drug Development: A Systematic Review[J].Clinical Pharmacology & Therapeutics,2013,94(3):336-348.

[18]MONLEÓN C,SPÄTH H M,CRESPO C,et al.Systematic literature review on implicit factors influencing the HTA deliberative processes in Europe[J].Journal of Market Access & Health Policy,2022,10(1):2094047.

[19]KÅLLBERG C,MATHIESEN L,GOPINATHAN U,et al.The Role of Drug Regulatory Authorities and Health Technology Assessment Agencies in Shaping Incentives for Antibiotic R&D: A Qualitative Study[J].Journal of Pharmaceutical Policy and Practice,2023,16:53.

[20]MUNDY L,FORREST B,HUANG L Y,et al.Health Technology Assessment and Innovation: Here to Help or Hinder?[J].International Journal of Technology Assessment in Health Care,2024,40(1):e37.

[21]JANSSENS R,BARBIER L,MULLER M,et al.How Can Patient Preferences Be Used and Communicated in the Regulatory Evaluation of Medicinal Products? Findings and Recommendations from IMI PREFER and Call to Action[J].Frontiers in Pharmacology,2023,14:1192770.

[22]MOUNTFORD N,CAI Y.Towards a Flatter Ontology of Institutional Logics: How Logics Relate in Situations of Institutional Complexity[J].International Journal of Management Reviews,2023,25(2):363-383.

[23]李梦颖,伍琳,王昕妍,等.我国医保谈判药品落地问题的多重制度逻辑分析与政策建议[J].中国药房,2024,35(14):1683-1689.

[24]FREEMAN R E.Strategic Management: A Stakeholder Approach[M].Boston:Pitman,1984.

[25]HE A J,BALI A S,RAMESH M.Active stewardship in healthcare: Lessons from China's health policy reforms[J].Social Policy & Administration,2022,56(6):925–940.DOI:10.1111/spol.12832.

[26]GUO W,WANG P,ZHANG Y,et al.Health Technology Assessment in China's Health Care Sector: Development and Applications[J].Health Systems & Reform,2023,9(3):2327099.DOI:10.1080/23288604.2024.2327099.

[27]曾润喜,莫敏丽.政府注意力的测量:路径、内容与展望[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,37(1):66-73.

[28]文宏.中国政府推进基本公共服务的注意力测量——基于中央政府工作报告(1954—2013)的文本分析[J].吉林大学社会科学学报,2014,54(2):20-26,171.

[29]陈星平,毕利娜,吴道友.中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告(1978—2017)文本分析[J].科技进步与对策,2018,35(23):155-160.DOI:10.6049/kjjbydc.L201808216.

[30]练宏.注意力分配——基于跨学科视角的理论述评[J].社会学研究,2015,30(4):215-241,246.

[31]THORNTON P H,OCASIO W.Institutional logics[M]//GREENWOOD R,OLIVER C,SAHLIN K,et al.The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism.London:SAGE,2008:99-129.

[32]GREENWOOD R,RAYNARD M,KODEIH F,et al.Institutional Complexity and Organizational Responses[J].Academy of Management Annals,2011,5(1):317-371.

[33]OCASIO W.Towards an Attention-Based View of the Firm[J].Strategic Management Journal,1997,18(S1):187-206.

[34]陶鹏,初春.府际结构下领导注意力的议题分配与优先——基于公开批示的分析[J].公共行政评论,2020,13(1):63-78.

[35]国家市场监督管理总局.药品注册管理办法(国家市场监督管理总局令第 27 号)[Z].2020.

[36]国家医疗保障局.基本医疗保险用药管理暂行办法(国家医疗保障局令第 1 号)[Z].2020.

[37]国家卫生健康委办公厅.关于规范开展药品临床综合评价工作的通知(国卫办药政发〔2021〕16 号)及附件《药品临床综合评价管理指南(2021 年版 试行)》[Z].2021.

[38]人力资源社会保障部.关于将 36 种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知(人社部发〔2017〕54 号)[Z].2017.

[39]国家医疗保障局.2026 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整申报指南[Z].2026.

[40]国家医疗保障局.国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答(2026 年版)[Z].2026.

[41]KROON A C,VAN DER MEER T,VLIEGENTHART R.Beyond Counting Words: Assessing Performance of Dictionaries, Supervised Machine Learning, and Embeddings in Topic and Frame Classification[J].Computational Communication Research,2022,4(2):528–570.DOI:10.5117/CCR2022.2.006.KROO.

[42]GILARDI F,ALIZADEH M,KUBLI M.ChatGPT Outperforms Crowd Workers for Text-Annotation Tasks[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2023,120(30):e2305016120.

[43]HALTERMAN A,KEITH K A.Codebook LLMs: Evaluating LLMs as Measurement Tools for Political Science Concepts[J].Political Analysis,2026,34(2):188-204.DOI:10.1017/pan.2025.10017.

[44]CARD D,BOYDSTUN A E,GROSS J H,et al.The Media Frames Corpus: Annotations of Frames Across Issues[C]//Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 2: Short Papers).Beijing:Association for Computational Linguistics,2015:438–444.DOI:10.3115/v1/P15-2072.

[45]GRIMMER J,STEWART B M.Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts[J].Political Analysis,2013,21(3):267-297.

[46]COHEN J.A coefficient of agreement for nominal scales[J].Educational and Psychological Measurement,1960,20(1):37-46.DOI:10.1177/001316446002000104.

[47]KRISTENSEN-MCLACHLAN R D,CANAVAN M,KÁRDOS M,et al.Are chatbots reliable text annotators? Sometimes[J].PNAS Nexus,2025,4(4):pgaf069.DOI:10.1093/pnasnexus/pgaf069.
[48]RAO J N K,WU C F J,YUE K.Some recent work on resampling methods for complex surveys[J].Survey Methodology,1992,18(2):209–217.
[49]HORVITZ D G,THOMPSON D J.A Generalization of Sampling Without Replacement From a Finite Universe[J].Journal of the American Statistical Association,1952,47(260):663-685.DOI:10.1080/01621459.1952.10483446.
[50]CARTER N,BRYANT-LUKOSIUS D,DICENSO A,et al.The Use of Triangulation in Qualitative Research[J].Oncology Nursing Forum,2014,41(5):545-547.
[51]国家药品监督管理局药品审评中心.创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则(试行)[Z].2025.
[52]国家药品监督管理局药品审评中心.以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则[Z].2021.
[53]国家药品监督管理局.真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则(试行)[Z].2020.
[54]国家药品监督管理局,国家卫生健康委员会,国家中医药管理局,等.药物临床试验质量管理规范(2026 年修订)[Z].2026.
[55]国家医疗保障局.谈判药品续约规则[Z].2026.
[56]国家医疗保障局.国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答(2025 年版)[EB/OL].(2025-07-10)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/7/10/art_109_17198.html.
[57]国家卫生健康委.关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知:国卫药政函〔2019〕80 号[EB/OL].(2019-04-09)[2026-10-08].https://www.nhc.gov.cn/yaozs/c100097/201904/6bc8f273684845d3ab76fed841eb42d2.shtml.
[58]国家药品监督管理局.国家药监局关于发布化学药品注册分类及申报资料要求的通告(2020 年第 44 号)[Z].2020.
[59]国家医疗保障局.国家医保局发布《参照药预沟通办法(试行)》[EB/OL].(2026-02-10)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/2/10/art_109_19642.html.
[60]国务院办公厅.关于健全药品价格形成机制的若干意见(国办发〔2026〕9 号)[Z].2026.
[61]国家医疗保障局办公室.关于开展真实世界医保综合价值评价试点工作的通知:医保办发〔2025〕15 号[EB/OL].(2025-09-23)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/23/art_109_17984.html.
[62]国家医疗保障局办公室.关于发布真实世界医保综合价值评价国家可信评价点网络公约和成员名单的公告[EB/OL].(2026-01-16)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/1/16/art_109_19379.html.
[63]国家医疗保障局.2026 年药品目录调整工作方案解读活动文字实录[EB/OL].(2026-05-26)[2026-10-08].https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/5/26/art_14_20707.html.
[64]Agenzia Italiana del Farmaco.Registri farmaci sottoposti a monitoraggio[EB/OL].[2026-10-06].https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio.
[65]岳晓萌,李钰翔,赵绯丽,等.医保药品目录调整之退出机制的国际经验借鉴[J].医药导报,2021,40(2):158-162.
[66]TÖRNBERG P.Best practices for text annotation with large language models[J].Sociologica,2024,18(2):67-85.DOI:10.6092/issn.1971-8853/19461.